

SEMIOLÓGIA DEL PACIENTE REUMATOLÓGICO

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Se estima que en España padece una enfermedad reumatológica alrededor de un 23% de la población, representando un 10% de las urgencias hospitalarias, un 15% de las consultas de atención primaria y hasta un 19% de las incapacidades laborales. Son una de las patologías más prevalentes en nuestro medio y por tanto, hemos de conocer cómo valorar a estos pacientes.

DIAGNÓSTICO

Los principales síntomas que nos encontramos son:

- Dolor: Se valora de manera similar al que podemos encontrar en otros órganos.
 - Localización: Óseo, articular, partes blandas. Los dolores no articulares habitualmente se manifiestan en movimientos activos, pero no en los pasivos. Hemos de tener en cuenta que el dolor generado en estructuras superficiales (pequeñas articulaciones de manos-pies, carpos, codos, tobillos, rodillas) tiende a ser localizado; mientras que el generado en estructuras profundas (hombros, columna vertebral, caderas y sacroilíacas) suele ser insidioso, continuo y mal definido.
 - Desencadente.
 - Maniobras que empeoren o que alivien el dolor.
 - Duración: Agudo, subagudo y crónico.
 - Modo de presentación: Episódico, aditivo (se van sumando dolores en otras localizaciones), migratorio (cambia la localización del dolor).
 - Tipo:
 - Mecánico: Empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Puede presentar rigidez, habitualmente tras el reposo de pocos minutos.
 - Inflamatorio: Más continuo, en reposo y con exacerbaciones nocturnas. Acompañado de rigidez, habitualmente matutina y de más de 1 hora de duración.
 - Intensidad.
 - Repercusión sobre calidad de vida.
- Tumefacción: Aumento de volumen de una estructura que indica proceso inflamatorio. Sólo se detecta cuando afecta a estructuras superficiales.
- Calor y enrojecimiento: Indicativos de proceso inflamatorio. El segundo suele relacionarse con procesos inflamatorios graves.
- Rigidez: Sensación temporal, percibida tras periodo de inactividad prolongado, de dificultad para llevar a cabo un movimiento. En general, los procesos inflamatorios se acompañan de rigidez con una duración superior a una hora mientras que los procesos mecánicos suelen presentar rigidez de corta duración.
- Impotencia funcional: Limitación en la movilidad de una estructura afecta por el dolor que aparece con el movimiento de ésta o por la rigidez asociada.
- Deformidad: Rara en fases iniciales, por lo que no es un motivo frecuente de consulta. No obstante, en fases avanzadas de la enfermedad, sobre todo si no está bien controlada es un hallazgo relativamente frecuente.

TRATAMIENTO

En el manejo del dolor reumatológico, al igual que cuando nos enfrentamos a dolor de otra

localización, debemos seguir una actitud escalonada:

- Analgésicos periféricos: En general tienen menores efectos que los AINE y últimos estudios revelan que sus beneficios podrían ser más bien pocos.:
 - Paracetamol: 500-650 mg/4 h ó 1g/6-8 h. No superando 4g/día. Precaución en pacientes con hepatopatía grave o alcohólicos.
 - Metamizol (Nolotil): 500-1000 mg/4-8h. No superando 6g/día. Precaución en anemia aplásica.
- AINE: Siguen siendo los más empleados en el tratamiento del dolor e inflamación leve-moderado. No obstante, no son recomendables en tratamientos crónicos, en pacientes ancianos y con comorbilidades por sus efectos secundarios sobre el tracto gastrointestinal y riesgo cardiovascular. Se recomienda asociar un IBP, sobre todo en personas mayores de 65 años con comorbilidades.
 - Ibuprofeno: 600 mg/6h ó 800 mg/8 h. No superando 2,4/día.
 - Dexibuprofeno: 300 mg/8-12 horas. No superando 1,2 g/día.
 - Naproxeno: 500 mg/12 h. No superando 1g/día.
 - Celecoxib: 200 mg/12 h. No superando 400 mg/día. Sobre todo si HTA o ERC.
- Opioides: Son los analgésicos más potentes. Se reservan para dolor que no se controla con los anteriores.
 - Tramadol: Si comprimidos de liberación inmediata 50-100 mg/6-8h (máximo 400 mg/día). Si comprimidos de liberación retardada 50-100 mg/12 h, no superando 400 mg/día.
 - Tapentadol: En paciente que no tomen otros opiáceos se administrará 50mg/12h. Si ya está en tratamiento con opiáceos se recomienda aumentar gradualmente con dosis de 50 mg/12h cada 3 días (máxima 500mg/24h).
 - Oxycodona-Naloxona.

Si el dolor es muy intenso, podríamos optar por medicación más potente si recurrir a la escalera analgésica ("Ascensor terapéutico").

NOTA

- Muy importante reconocer aquellos síntomas y signos que orienten a proceso inflamatorio, fundamentalmente el dolor y cómo manejarlo.

BIBLIOGRAFÍA.

- Larrosa Padró M. Anamnesis y exploración física de las enfermedades reumáticas. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 17: 93-98.
- Díaz González F. Analgésicos periféricos. AINE. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 52: 297-302.
- Revenga Martínez M. Opioides. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 53: 303-307.